



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ليلي فرحات مصطفى سيد
المحافظة : الشرقية الحي / المدينة : الزقازيق
رقم البطاقة : 27307011301002 رقم التليفون : 01114980331
العمر (تاريخ الميلاد) : 01-07-1973 المهنة : حداد مسلح
العنوان : ~
تاريخ تسجيل الإستمارة : 04-10-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي الفقرات القطنيه بالصبغه
قسم العلاج :
الاورام

[10581]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. ----- /د. ----- /د. ----- /د. -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ليلى فرحات مصطفى سيد National ID: 27307011301002	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

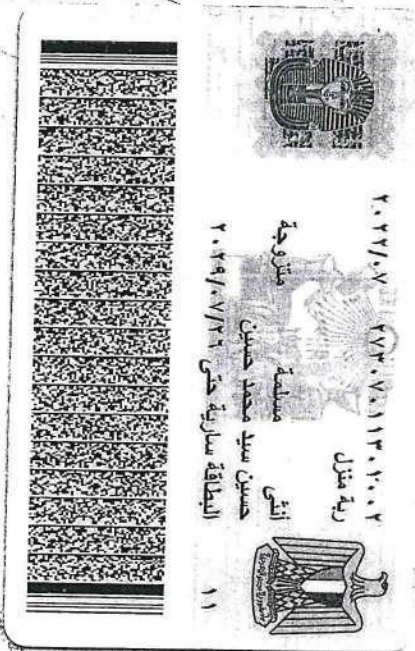
نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of the lumbar spine

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



MDT FORM

6/11/2028 G

Name	ليلى فؤاد حسن	MRN	4333/24
Age	52	ID	1-10-5072495
Menopausal status	Post Menopausal	Phone	1000904395
NRS SCORE		Marital status	CV 2.0.112.1005
BMI		Family history	-ve
CO morbidity	DM II HTN, TAD, ves stone removed	REASON OF MDT	Post operative

Clinical Data

BX:	IDC			R	L
ER:	PR:	HER 2:	Ki67:		
0/8	0/8	3	22%		
Sonomammography:					
Post NACT TCHPXX				TNM	
Mets Workup: Post Rt BCS 85 ENB					
↳ Pre Metastasis • 0/4 Nodes					

Recommendations: No residual tumor &
 ↳ To, No complete response

Omnia Fawzy
26/10/2025

MDT OUTCOME & PLAN

① PORT
 ② Continue phesgo one year

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د/انور محمد	د/هاجر عبد الحفيظ	د/اماني حبيب			

Name: ليلى فرحات مصطفى سيد		
MR. : 1827		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشر بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته تاريخ وساعة الدخول : تاريخ وساعة الخروج :		
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient was initially diagnosed with primary right-breast cancer, clinical stage T3 N1, hormone-receptor positive (ER-VE, PR-VE) and HER2-positive. Neoadjuvant therapy with trastuzumab, pertuzumab, and chemotherapy (TCHP) was initiated in October 2025, followed by completion of radiation therapy after breast-conserving surgery (BCS). At the time of the note, the patient was receiving treatment through a port for cycle 10 of the PHESGO regimen, with a documented left ventricular ejection fraction (EF) of 61 %. Cycles 11 and 12 of PHESGO were scheduled, with the next dose due on 26 February. The pharmacy note indicated that the patient was to receive cycle 11 of PHESGO at the next pharmacy visit. The oncology note documented preparation for cycle 13 of PHESGO, a new echocardiogram performed on the same day, and planning for cycles 14 and 15 with associated pharmacy coordination. An echocardiogram performed on 8 April showed an EF of 62 %, and the patient had a pharmacy visit for administration of cycle 14 of PHESGO. The patient presented with left shoulder pain while on cycle 15 of PHESGO, and an MRI of the left shoulder was ordered for further evaluation. According to the patient, she has received 17 cycles of HP to date; follow-up imaging of the breast and shoulder was performed in July 2026, revealing acroclavicular joint osteoarthritis. The patient has received 17 cycles of HP to date.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 19-09-2026
	الطبيب المعالج : dina makram	
يعتمد ,		

Patient Name : الأستاذة / ليلي فرحات مصطفى	Request No. : 13006052
Patient No. : 27307011301002	Request Date : 13/10/2025
Path No. : 3130/25	Verification Date : 18/10/2025
Sex : Female	Financial Category : جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age : 52 Y	Department : Out Patient
Referreing Doc :	Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

CLINICAL DATA:

Right breast cancer, Post NACT

NATURE OF SPECIMEN:

Right WLE & ALN specimens

GROSS EXAMINATION:

- 1- Right ALN: A fibro fatty tissue piece measured 4x3 cm & entangling 14 nodules up to 0.7x0.7cm.
- 2- Right WLE specimen measured 7x6x3.5cm , with covering skin ellipse measured 3x2cm
- Tumor extent
- o Number: A firm gryish white tumor bed site (clipped)
- o Size: 2x1x1 cm
- o Skin involvement: Free grossly
- Distance from margins: 0.4 cm from lateral margin (least deep margin)

Block designation :

- 1.Superior
- 2.inferior
- 3.Lateral
- 4.medial
5. deep
- 6.SLNB
- 8,7clipped area

Grossing By :Dr.Heba Hassan Adly

Frozen section :Free margins &free (0/4) , examined by (Prof Dr.Maha Guimei)

Microscopic examination:

Right breast ; WLE & ALN blosy :

- Histological type :No residual tumor

Verified by :

Dr.Heba Hasan



Patient Name : الأستاذة / ليلى فرحات مصطفى
Patient No. : 27307011301002
Path No. : 3130/25
Sex : Female
Age : 52 Y
Referring Doc :

Request No. : 13006052
Request Date : 13/10/2025
Verification Date : 18/10/2025
Financial Category : جوستاف روسي - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

- Ductal carcinoma in situ: No
- Skin involvement: Free
- Lymph node involvement: Free (0/4)
- Angio invasion: No
- Perineural invasion: No
- Resection Margins: Free all resected margins

DIAGNOSIS:

Right breast ; Wide local excision & Axillary lymph node dissection , post NACT :

- No residual tumor tissue
- Free all resected margin, free skin
- Free ALNs (0/4) with therapy effect
- Stage : ypT0, ypN0 , ypMx
- RCB : 0, Viability 0 %

Signature

Prof Dr.Maha Guimel
Dr.Heba Hassan Adly

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Printing Date : 26/10/2025 08:25:40

Page 2 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



Patient Name	: الأستاذة / ليلى لرحات مصطفى سيد احمد	Request No.	: 13009608
Patient No.	: 27307011301002	Request Date	: 24/11/2024
Path No.	: 4587/24	Verification Date	: 08/12/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مياثره
Age	: 51 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Right breast 11 O'clock mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 24/11/2024

Gross Examination:

- 3 grayish white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted.

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
- * Ductal carcinoma in situ: No remarkable DCIS.
- * Perineural invasion: Not detected.
- * Angioinvasion: Not detected.

Diagnosis:

Right breast mass. Tru-cut biopsy:

Invasive duct carcinoma, Grade II.

For further IHC (ER, PR, Her2, Ki67).

Signature

Prof. Dr. Lubna Omar
Dr. Menna Nabil.

مستح مله
10/12/2024

Verified by :

DR. Menna Nabil

Printing Date : 10/12/2024 09:56:22

Page 1 of 1

Printing By : marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Women's Health Outreach Program

Name: Laila farahat

Date: 16-3-2025

Contrast Enhanced Digital Mammography

Clinical summary:

A 52 years old female patient, diagnosed IDC grade II

Technique

MLO and CC views (low energy & recombined post contrast)

Targeted High resolution ultrasound

Detailed Findings:

Density: ACR c

Background Uptake: minimal

Right breast

- Low energy (non contrast images) show : a UOQ irregular hyperdense mass
- No asymmetry, distortion or suspicious calcifications.
- Recombined (post contrast) images : showing the above mentioned lesion showing avid pathological uptake.
- Ultrasound demonstrated: right breast 10 o'clock about 6 CMFN irregular speculated margins with heterogeneous echopattern measuring about 3.9x2.6 cm.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Few enlarged suspicious looking group I axillary Lymph nodes with cortical thickness measuring about 9 mm.



Left breast

- Low energy (non contrast images) show : no masses, asymmetry, distortion or suspicious calcifications.
- Recombined (post contrast) images show: no pathological uptake.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic masses.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

Left breast (BIRADS 1): Normal

Right breast (BIRADS VI): single right UOQ pathologically proven IDC with suspicious looking lymph nodes.

Name: Mrs. Layla Farahat Moustafa

Date: 27/04/2025

Ref. By: Prof. Dr.: Health Insurance

MULTI-SLICE PET/CT EXAMINATION OF THE BODY:

Clinical History:

- A 51 y/o female with pathologically proven Rt. breast cancer in November 2024.
- Her CT done in December 2024 revealed small lung nodules and osteosclerotic lesions.
- Her bone scan done in February 2025 was free from metastases.
- PET/CT is done for status evaluation and staging.

Technique:

- For the aforementioned patient we have done a total body PET scan one hour after IV injection of 300 MBq of 18 F-FDG.
- 16 MSCT scan was performed using GE Q-Clear simultaneously and used for attenuation correction, anatomical localization and diagnosis.
- Max. variant of SUV; a Semi-quantitative analysis would be done for selected ROI.s and the normal threshold is < 2.5.

Findings:

A) Both Breasts and Mammary-Related LN.s:

- Rt. breast UOQ mass (= 4.6 x 4 cm) is seen eliciting increased tracer uptake with **SUVmax of 5.2**.
- Normal Lt. breast appearance with no masses or dense tracer fixing foci.
- Few enlarged Rt. axillary LN.s (up to 2.2 cm) are seen eliciting mildly increased tracer uptake with **SUVmax of 3.3**.
- No other pathologic enlarged or dense tracer fixing mammary-related LN.s.

B) Head and Neck:

- Normal appearance of nasopharynx, oropharynx and larynx.
- Normal appearance of thyroid, sub-mandibular and parotid salivary glands.
- No pathologic enlarged or dense tracer fixing cervical LN.s seen.

OPINION:

- The study findings are of:

- ✓ *Glucose avid Rt. breast UOQ mass; that should be regarded as being consistent with **Active Tumor Biology** and **Local Disease Involvement**.*
- ✓ *Glucose avid few enlarged Rt. axillary LN.s; that should be regarded as being consistent with **Active Tumor Biology** and **Regional Nodal Disease Involvement**.*
- ✓ *Few bilateral lung nodules; that are currently **Too Tiny** to be characterized by **FDG PET**; warranting close radiological follow up.*
- ✓ ***Free** rest of the surveyed body from any other significant glucose avid foci that would assign to any other serious pathology.*

- **PET/CT** therapy monitoring would be advisable.

Thanks for your referral,

Truly yours,

Dr. Mohamed Hassan Hassouna, MSc.

Dr. Mohamed Fat'hy Ragab, MD.

Nuclear Medicine Unit

وحدة الطب النووي

Laila Farahat Moustafa

Date: 22/02/2025

Tc99m MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History

- A 51-year-old patient with history of breast cancer.

Technique

- Anterior and posterior whole-body scans were acquired 2 hours post injection of 20 mCi of the tracer.

Findings

- No definite evidence of bone secondaries could be seen.
- Degenerative changes are noticed at different levels of spine and large joints.

IMPRESSION

- The skeleton is scintigraphically free from metastases.

Appreciated,

Dr. Hossam Sekkina, M.Sc.

Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine



25
الدائرة

Hotline

02 21 29 2000

www.ahramscan.com

فرع حلوان : 64 شارع عبد الرحمن تقاطع شارع عبد الله فوق بنك مصر فرع نادي الاسمنت
فرع فيصل : 434 شارع الملك فيصل (فوق مستشفى تبارك للأطفال) الجيزة
فرع الدقي : 92 شارع التحرير - برج ساهدار الطبي - الدور الثالث
فرع شبرا : 128 شارع شبرا - أمام قسم الساحل - بجوار سنترال شبرا
فرع أكتوبر : رنا مول بعد الحصري والتوحيد والنور فوق سوبر ماركت أولاد رجب - الدور الثاني

Bone Scan

[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

ECHO REPORT

NAME: *ليلى قمر حاتم محمد* DATE: 14 / 1 / 2026
ID NUMBER: ٤٢٣٣ / ٠.٠٤ SEX: F AGE:

EF	61%	55-75%	PWT	0.8	0.6-1.1cm
LVEDD	4.5	3.5-5.8cm	AO.R	2.3	3-3.7cm
LVESD	2.5	2-4cm	LA	3.3	2-4cm
FS	29%	25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.9	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV Dimensions *Normal*

LV Wall Thickness *Normal*

LV Diastolic Function *Normal*

SWMA *No. RWMA*

LA and Ao Root Dimensions *Normal*

Mitral Valve *Trivial MR*

Aortic Valve *N*

Tricuspid Valve *N*

Pulmonary Valve

Right Side and Systolic Function *TAPSE = 2.3*

Intracardiac Masses and Effusion

DR.

[Signature]

